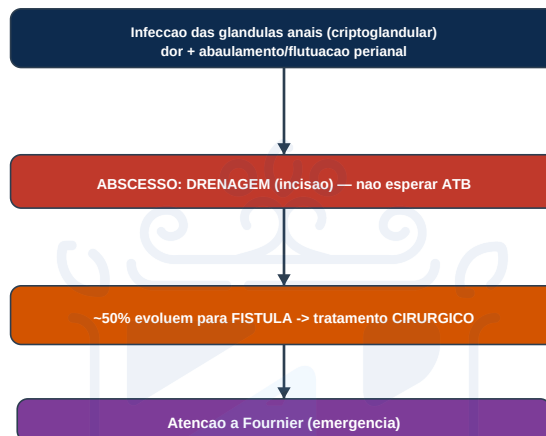


ABSCESO E FÍSTULA PERIANAL — DRENAR

FLUXOGRAMA — CONTÍNUO DOENÇA CRIPTOGLANDULAR

ABSCESO -> FÍSTULA — DRENAR O ABSCESO



ABSCESO PERIANAL

DRENAGEM É O TRATAMENTO

- Infecção das glândulas anais (criptoglandular); cerca de 50% evoluem para fístula perianal
- Quadro: dor perianal contínua e progressiva, abaulamento, calor, flutuação; febre nos mais extensos
- Tratamento DEFINITIVO é a DRENAGEM (incisão) — o antibiótico isolado NÃO resolve o abscesso
- Fatores de risco: doença de Crohn, diabetes, imunossupressão (HIV/TB), mulheres
- Sempre acompanhar com proctologia (risco de fístula e recorrência)

ABORDAGEM DO ABSCESO NO PS

Rx ANALGESIA + DRENAGEM + ATB

Analgesia: Dipirona 1 g EV; Cetoprofeno 100 mg EV; Tramadol 100 mg EV se intensa

Drenagem local (se ponto de flutuação acessível): assepsia, anestesia local com lidocaína 2% com vaso, incisão e drenagem do pus

NÃO suturar — manter o orifício aberto para drenagem e cicatrização por 2ª intenção

Drenagem em CENTRO CIRÚRGICO se: acesso difícil, analgesia insuficiente, pouca colaboração do paciente

ATB associado: Ciprofloxacino 500 mg 12/12h + Metronidazol 250 mg (2 cp) 8/8h por 7 dias

Indicações fortes de ATB: celulite extensa, imunossupressão, diabetes, sinais sistêmicos, valvopatia/prótese

RED FLAG — GANGRENA DE FOURNIER

NÃO PERDER

- Dor desproporcional, toxemia, crepitação, necrose/bolhas, evolução rápida = fasciite necrotizante perineal (Fournier)
- EMERGÊNCIA: ressuscitação + ATB de amplo espectro + DESBRIDAMENTO cirúrgico urgente e amplo
- Diabéticos e imunossuprimidos são os mais propensos
- Não retardar a cirurgia aguardando exames
- Mortalidade elevada se o desbridamento for tardio

FÍSTULA PERIANAL — CLASSIFICAÇÃO DE PARKS

Tipo (Parks)	Trajetos / frequência
I — Interesfincteriana	Entre os esfínteres; ~45% (mais comum)
II — Transesfincteriana	Atravessa o esfíncter externo; ~30%
III — Supraesfincteriana	Acima do puborretal; ~20%
IV — Extraesfincteriana	Fora do aparelho esfinteriano; ~5% (complexa)

FÍSTULA — GOODSALL E TRATAMENTO

EXCLUSIVAMENTE CIRÚRGICO

- Clínica: drenagem purulenta/fecaloide crônica pelo orifício externo perianal
- Regra de GOODSALL: orifício externo ANTERIOR -> trajeto retilíneo à cripta correspondente; orifício POSTERIOR (ou > 3 cm da borda) -> trajeto curvilíneo para a linha média posterior
- Imagem em fístulas complexas: RM de pelve (padrão), US endorretal, fistulografia
- SIMPLES (< 30% do esfíncter, superficial, interesfincteriana): fistulotomia/fistulectomia
- COMPLEXAS (supra/extraesfincteriana, transesfincteriana alta, Crohn, RT, neoplasia): sedenho (seton), retalho de avanço, cola, LIFT — risco de incontinência
- Tratar a infecção ATIVA primeiro: Ceftriaxona 500 mg IM/dia (ou Cipro 500 mg 12/12h) + Clindamicina 300 mg 8/8h (ou Metronidazol) por 7 dias

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com dor perianal + abaulamento/flutuação (abscesso) OU drenagem crônica (fístula).
- Sinais de Fournier (crepitação/necrose/toxemia): ____; comorbidade (DM/imunossupressão): ____.
- Conduta: drenagem realizada ____ (local/CC), ferida aberta (sem sutura); ATB ____; analgesia.
- Encaminhamento à proctologia (programar fistulotomia/seton) ou cirurgia URGENTE se Fournier.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com abscesso perianal flutuante e doloroso. Qual é o tratamento definitivo?

- A) Antibiótico oral isolado
- B) Drenagem cirúrgica (incisão), mantendo a ferida aberta para cicatrização por segunda intenção
- C) Apenas banho de assento
- D) Corticoide
- E) Observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tipo mais comum de fístula perianal na classificação de Parks?

- A) Extraesfincteriana
- B) Interesfincteriana (~45%)
- C) Supraesfincteriana
- D) Transesfincteriana alta
- E) Todas igualmente frequentes

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Diabético com dor perineal intensa, crepitação, necrose cutânea e toxemia. Qual a conduta?

- A) Antibiótico oral ambulatorial
- B) Suspeitar de gangrena de Fournier: ressuscitação + ATB amplo + desbridamento cirúrgico urgente
- C) Apenas analgesia
- D) Banho de assento e alta
- E) Drenagem eletiva em 1 semana

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Segundo a regra de Goodsall, um orifício fistuloso externo posterior tende a:

- A) Ter trajeto retilíneo até a cripta correspondente
- B) Ter trajeto curvilíneo dirigindo-se à linha média posterior
- C) Não ter cripta de origem
- D) Drenar para a bexiga
- E) Ser sempre superficial

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o tratamento de uma fístula perianal simples (superficial, interesfincteriana, < 30% do esfíncter)?

- A) Apenas antibiótico
- B) Fistulotomia/fistulectomia
- C) Sedenho (seton) sempre
- D) Amputação abdominoperineal
- E) Observação indefinida

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O tratamento do abscesso perianal é a drenagem cirúrgica (incisão), sem suturar, deixando cicatrizar por segunda intenção. O antibiótico é adjuvante (celulite, imunossupressão, sinais sistêmicos), não substitui a drenagem.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A fístula interesfincteriana é a mais comum (~45%) na classificação de Parks; seguem-se transesfincteriana (~30%), supraesfincteriana (~20%) e extraesfincteriana (~5%).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O quadro é gangrena de Fournier (fasciite necrotizante perineal): emergência que exige ressuscitação, antibiótico de amplo espectro e desbridamento cirúrgico urgente e amplo — não se deve retardar.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Pela regra de Goodsall, orifício externo posterior tem trajeto curvilíneo em direção à linha média posterior; orifício anterior tende a trajeto retilíneo até a cripta correspondente.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Fístulas simples (superficiais, interesfincterianas, com < 30% de esfíncter envolvido) são tratadas com fistulotomia/fistulectomia; as complexas exigem técnicas poupadoras de esfíncter (seton, retalho, LIFT).

SM24
Suporte ao Plantão Médico